

1) Article Amue :

CONTROVERSE : e-Santé, la médecine pour tous, mais à quel prix ?

I. INTRODUCTION

L'e-santé désigne l'ensemble des domaines où les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont mises au service du bien-être et de la santé. Définie par l'OMS comme « les services du numérique au service du bien-être de la personne », son essor se caractérise par une rapidité de diffusion sans précédent. La télémédecine (téléconsultation, télé-expertise) et les objets connectés ou m-santé (santé mobile) en sont les piliers. L'utilisation du Dossier Médical Partagé (DMP) est un exemple de système d'information clé pour le suivi des patients, et la pratique de la télémédecine dans des spécialités comme la néphrologie est désormais bien engagée (Citarda et al., 2019).

II. Les promesses : l'efficacité au service de l'accès et de la personnalisation

La santé numérique améliore l'accessibilité et la rapidité des soins, contribuant à réduire les inégalités territoriales. Le développement de la télémédecine vers des structures isolées, comme les EHPAD, constitue une réponse concrète à la pénurie de médecins.

Au-delà de l'accès, la personnalisation et la prévention sont au cœur de cette transformation : l'analyse génétique et l'IA permettent une médecine plus précise et plus réactive. Les études montrent également l'efficacité de l'e-santé dans le suivi des maladies chroniques et des troubles dépressifs grâce aux applications mobiles. Les montres connectées renforcent cette dynamique en assurant un suivi continu d'indicateurs de santé au quotidien.

Ces avancées ouvrent enfin la voie à une réduction significative des coûts pour les systèmes de santé.

III. Les risques et dérives : le soin transformé en marché

Le développement de l'e-santé soulève des risques majeurs pour la sécurité et l'équité des soins. La protection des données reste le principal enjeu : au-delà du piratage, l'usage des informations personnelles soulève des questions éthiques, comme le profilage ou la discrimination des patients. Une dérive notable est la marchandisation du secteur, notamment dans le "wellness", qui transforme la promesse de soins en véritable opportunité commerciale. La crainte d'une médecine déshumanisée, avec la réduction des consultations physiques, fragilise la relation soignant-soigné et pose un défi particulier en santé mentale, où le contact humain reste essentiel pour la qualité du soin. Enfin, la persistance de la fracture numérique creuse de nouvelles inégalités d'accès : comme le montre la figure « La fracture numérique en France », 14 % des Français n'ont pas Internet et restent exclus de cette santé numérique, accentuant le risque de marginalisation des populations les plus vulnérables.

Source : Baromètre du numérique. (2015)

[esm45-infographie-fracture-numerique-600.jpg](#) // mettre le lien sur le site, c est le lien de l'image.

IV. La controverse : un débat contrôlé et une question de pouvoir

Le véritable problème n'est pas technique, mais politique. Le débat est influencé par de nombreux conflits d'intérêts. Les grandes entreprises privées dominent l'innovation et la gestion de nos données, créant un rapport de force déséquilibré : nous sommes totalement transparents, tandis que leurs pratiques restent opaques. Cette logique de profit appliquée à la santé alimente une méfiance publique difficile à lever. Face à la puissance mondiale des GAFAM, tels que Google, Apple... et à des lois qui évoluent trop lentement, la régulation peine à suivre. La question centrale devient alors : la technologie sert-elle réellement le soin, ou la santé est-elle simplement devenue un marché pour l'industrie technologique ?

V. CONCLUSION

Pour relever la controverse autour de l'e-santé — offrir une médecine accessible à tous tout en garantissant sécurité et éthique — il est essentiel de mettre en place une gouvernance publique de la santé numérique, de développer une éthique des algorithmes et de sécuriser les données grâce à des technologies comme la Blockchain. L'éducation numérique en santé reste également un levier indispensable pour réduire les inégalités et garantir une utilisation responsable des outils numériques.

Comme l'a évoqué Anne-Sophie Cases lors de son interview, l'empowerment du patient connecté ouvre une perspective prometteuse : mieux informé et accompagné, le patient peut gagner en autonomie et en pouvoir d'action sur son parcours de soin, même si, selon elle, cette évolution doit rester équilibrée et préserver avant tout le contact humain.

PDF ARTICLE AMUE :

LA COLLECTION NUMÉRIQUE

DE L'AGENCE DE MUTUALISATION DES
UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU
DE RECHERCHE ET DE SUPPORT À
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU À LA
RECHERCHE



DÉCEMBRE
2025

E-SANTÉ, LA MÉDECINE POUR TOUS, MAIS À QUEL PRIX ?

I. INTRODUCTION

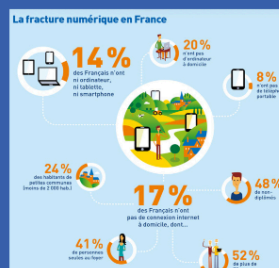
L'e-santé désigne l'ensemble des domaines où les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont mises au service du bien-être et de la santé. Définie par l'OMS comme « les services du numérique au service du bien-être de la personne », son essor se caractérise par une rapidité de diffusion sans précédent. La télémédecine (téléconsultation, télé-expertise) et les objets connectés ou m-santé (santé mobile) en sont les piliers. L'utilisation du Dossier Médical Partagé (DMP) est un exemple de système d'information clé pour le suivi des patients, et la pratique de la télémédecine dans des spécialités comme la néphrologie est désormais bien engagée (Citarda et al., 2019).

II. Les promesses : l'efficacité au service de l'accès et de la personnalisation

La santé numérique améliore l'accessibilité et la rapidité des soins, contribuant à réduire les inégalités territoriales. Le développement de la télémédecine vers des structures isolées, comme les EHPAD, constitue une réponse concrète à la pénurie de médecins. Au-delà de l'accès, la personnalisation et la prévention sont au cœur de cette transformation : l'analyse génétique et l'IA permettent une médecine plus précise et plus réactive. Les études montrent également l'efficacité de l'e-santé dans le suivi des maladies chroniques et des troubles dépressifs grâce aux applications mobiles. Les montres connectées renforcent cette dynamique en assurant un suivi continu d'indicateurs de santé au quotidien. Ces avancées ouvrent enfin la voie à une réduction significative des coûts pour les systèmes de santé.

III. Les risques et dérives : le soin transformé en marché

Le développement de l'e-santé soulève des risques majeurs pour la sécurité et l'équité des soins. La protection des données reste le principal enjeu : au-delà du piratage, l'usage des informations personnelles soulève des questions éthiques, comme le profilage ou la discrimination des patients. Une dérive notable est la marchandisation du secteur, notamment dans le « wellness », qui transforme la promesse de soins en véritable opportunité commerciale. La crainte d'une médecine déshumanisée, avec la réduction des consultations physiques, fragilise la relation soignant-soigné et pose un défi particulier en santé mentale, où le contact humain reste essentiel pour la qualité du soin. Enfin, la persistance de la fracture numérique creuse de nouvelles inégalités d'accès : comme le montre la figure « La fracture numérique en France », 14 % des Français n'ont pas Internet, et restent exclus de cette santé numérique, accentuant le risque de marginalisation des populations les plus vulnérables.



Source : Baromètre du numérique. (2015)

IV. La controverse : un débat contrôlé et une question de pouvoir

Le véritable problème n'est pas technique, mais politique. Le débat est influencé par de nombreux conflits d'intérêts. Les grandes entreprises privées dominent l'innovation et la gestion de nos données, créant un rapport de force déséquilibré : nous sommes totalement transparents, tandis que leurs pratiques restent opaques. Cette logique de profit appliquée à la santé alimente une méfiance publique difficile à lever. Face à la puissance mondiale des GAFAM, tels que Google, Apple... et à des lois qui évoluent trop lentement, la régulation peine à suivre. La question centrale devient alors : la technologie sert-elle réellement le soin, ou la santé est-elle simplement devenue un marché pour l'industrie technologique ?

V. CONCLUSION

Pour relever la controverse autour de l'e-santé — offrir une médecine accessible à tous tout en garantissant sécurité et éthique — il est essentiel de mettre en place une gouvernance publique de la santé numérique, de développer une éthique des algorithmes et de sécuriser les données grâce à des technologies comme la Blockchain. L'éducation numérique en santé reste également un levier indispensable pour réduire les inégalités et garantir une utilisation responsable des outils numériques. Comme l'a évoqué Anne-Sophie Cases lors de son interview, l'empowerment du patient connecté ouvre une perspective prometteuse : mieux informé et accompagné, le patient peut gagner en autonomie et en pouvoir d'action sur son parcours de soin, même si, selon elle, cette évolution doit rester équilibrée et préserver avant tout le contact humain.

Bibliographie/Documentation : // à voir comment on l'insère sur le site

enlever les trucs inutiles

Voici notre bibliographie :

En anglais :

- 1) AlShehri, Waleed S., et Yasser Y. Khojah. 2025. « Impact of E-Health Literacy on Diabetes Self-Care Activities Among People With Type 2 Diabetes Attending Primary Healthcare Centers in Makkah City, Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study, 2025 ». *Cureus* 17 (7): e87968. <https://doi.org/10.7759/cureus.87968>.
- 2) Alter, Isaac L., Carla Dias, Jack Briano, et Anaïs Rameau. 2025. « Digital health technologies in swallowing care from screening to rehabilitation: A narrative review ». *Auris Nasus Larynx* 52 (4): 319-26. <https://doi.org/10.1016/j.anl.2025.05.002>.
- 3) Atmaja, Ferry Tema, Cedric Hsi-Jui Wu, Revanth Kumar Guttena, et Andreawan Honora. 2024. « Intention to Use Telemedicine Services during a Health Crisis: A Motivation-Opportunity-Ability Theory Approach ». *International Journal of Consumer Studies* 48 (3): e13044. <https://doi.org/10.1111/ijcs.13044>.
- 4) Vasdev, Nupur, Tanisha Gupta, Bhakti Pawar, Anoothi Bain, et Rakesh Kumar Tekade. 2024. « Navigating the future of health care with AI-driven digital therapeutics ». *Drug Discovery Today* 29 (9): 104110. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2024.104110>.
- 5) Rhodrick, Nyasha Musakuro. 2025. Investigating the Current State of the Adoption of E-Health Tools for Digital Mental Health Services in a Selected South African Higher Education Institution. *Business Ecosystem*. (Istanbul, Turkey) 7 (2): 75-87. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v7i2.698>.
- 6) Wicks, Paul, Jon Stamford, Martha A. Grootenhuis, Lotte Haverman, et Sara Ahmed. *Innovations in E-Health*. (Dordrecht, Netherlands) 23, n° 1 (2014): 195-203. <https://doi.org/10.1007/s11136-013-0458-x>.
- 7) Musakuro, Rhodrick N., et Liiza Gie. 2025. Strategies for sustainable adoption of e-health tools for digital mental health services. Original Research. (Tygervally, South Africa) 23. <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v23i0.3053>.
- 8) Penedo, Frank J, Laura B Oswald, Joshua P Kronenfeld, Sofia F Garcia, David Cella, et Betina Yanez. 2020. « The Increasing Value of eHealth in the Delivery of

Patient-Centred Cancer Care ». The Lancet Oncology 21 (5): e240-51.
[https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(20\)30021-8](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30021-8).

- 9) Hareem, Amina, Ieva Stupans, Joon Soo. Park, Julie E. Stevens, et Kate Wang. 2024. « Electronic health records and e-prescribing in Australia: An exploration of technological utilisation in Australian community pharmacies ». International Journal of Medical Informatics 187 (juillet): 105472.
<https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2024.105472>.

En français :

- 10) GLOANNEC & al. 2017. « LA SANTÉ CONNECTÉE ». Module interprofessionnel de santé publique - MIP. EHESP.
<https://documentation.ehesp.fr/memoires/2017/mip/groupe%2024.pdf>.
- 11) Lourdaïs, Chloé. 2022. « Optimisation d'une interface numérique de santé à distance pour une meilleure expérience-patient ». These de doctorat, École centrale de Nantes. <https://theses.hal.science/tel-04128753>.
- 12) Py, Ulysse. 2024. « E-santé et milieu carcéral ». These de doctorat, Université de Lorraine. <https://theses.fr/2024LORR0275>.
- 13) Salmon, Frédéric Durand, et Loïc Le Tallec. 2014. « La e-santé : de nouveaux usages pour les technologies individuelles en santé publique ». Santé Publique. Annales des Mines - Réalités industrielles 2014 (4): 70-75.
<https://doi.org/10.3917/rindu.144.0070>.
- 14) Sossou, Komlanvi Etienne. 2023. « Appropriation de la plateforme de télépathologie I-PATH-INCTR dans la prise en charge des cancers pédiatriques au Mali et en RDC ». These de doctorat, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III.
<https://theses.hal.science/tel-04876097>
- 15) Vallancien, Guy. 2015. « La médecine sans médecin ?. Le numérique au service du malade ». <https://doi.org/10.3917/gall.valla.2015.01>.
- 16) Béorchia, Sylvain. 2017. « e-Médecine, e-santé et informatique - entre espoirs technologiques et désillusion humaniste ». Gestion. Hegel 4 (4): 289-99.
<https://doi.org/10.4267/2042/63780>.
- 17) Cases, Anne-Sophie. 2017. « L'e-santé : l'empowerment du patient connecté ». Santé Publique. Journal de gestion et d'économie médicales 35 (4): 137-58.
<https://doi.org/10.3917/jgem.174.0137>.

- 18) Chambaud, Laurent. 2023. « 6. Les nouvelles technologies : l'avenir de notre santé ? » In : *Santé publique : un nouveau monde ?*, Rennes : Presses de l'EHESP, pages 77-89.
- 19) Citarda, Salvatore, Anne-Laure Camarroque, Guillaume Seret, et al. 2019. « Pratique de la e-santé en néphrologie en France : Résultats de la première enquête sur la télénéphrologie ». *Néphrologie & Thérapeutique* 15 (6): 452-60.
<https://doi.org/10.1016/j.nephro.2019.06.001>.
- 20) Debet, Anne. 2017. « Objets connectés et santé ». *Journal du Droit de la Santé et de l'Assurance - Maladie (JDSAM)* 15 (1): 34-42.
<https://doi.org/10.3917/jdsam.hs2.0034>.

Chronologie :

changer avec Dams

Période/D ate	Titre	Contexte
Années 1960	Les premières expérimentations modernes de la télé médecine.	Premiers projets aux États-Unis, notamment pour des liaisons entre hôpitaux universitaires et centres isolés dans un contexte de recherche.
2004	Officialisation de l'e-health	L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) adopte officiellement le terme " eHealth ".Jalon conceptuel marquant l'application des TIC au domaine de la santé à l'échelle mondiale.
2010 (19 octobre)	Décret Français sur la Télé médecine	Jalon réglementaire majeur qui définit les cinq actes de télé médecine : téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance et régulation médicale .

2013-2015	Émergence des Nouveaux Usages en Santé Publique	Période de réflexion sur l'intégration des technologies individuelles et mobiles dans les parcours de soins, marquant le début de la reconnaissance du potentiel de la santé mobile (m-santé).
2017	Année de la Réflexion Éthique et de l'Empowerment	Nombreuses publications s'interrogeant sur l'impact des objets connectés sur la santé, l'autonomisation du patient connecté (<i>empowerment</i>), et les enjeux éthiques et humanistes face aux avancées technologiques.
2018 (15 septembre)	Entrée en vigueur de la prise en charge par l'Assurance Maladie des actes de télémedecine (téléconsultation et téléexpertise).	Point de bascule pour le déploiement de masse de la télémedecine en France, la rendant accessible et remboursable.
2020	Crise sanitaire liée à la COVID-19 et accélération des usages numériques en santé.	La téléconsultation est temporairement libéralisée, conduisant à une adoption massive et un changement d'échelle des pratiques.
2024-2025	Intensification des recherches et publications sur l'Intelligence Artificielle (IA) en e-santé.	Les travaux se concentrent sur l'intégration de l'Intelligence Artificielle (thérapeutiques numériques pilotées par IA), l'extension de la e-santé à des milieux spécifiques (comme le milieu carcéral), et la recherche de stratégies d'adoption durable des outils numériques en santé mentale.

Equipe :

mettre les photos, les noms bien orthographiés

Experts :

Valentin s'en occupe

Argumentation :

à voir

**ON DOIT FAIRE NOTRE TEXTE
D'ORAL AU PLUS VITE**